

Soins infirmiers — Appareil cardio-vasculaire (1ère année)

Diapositive 1

COURS DE SOINS INFIRMIERS EN RAPPORT AVEC L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE
AU PROGRAMME DE FORMATION EN PREMIERE ANNEE COMMUNE (Licence 1)

Diapositive 2

TITRES DES COURS

LE POULS

LA TENSION

ARTERIELLE

COLLAPSUS CARDIO-VASCULAIRE ET

CHOC

LES

INJECTIONS

LES

HEMORRAGIES

LA

PERFUSION

LA

TRANSFUSION

PRINCIPAUX SIGNES D'ATTEINTE DE L'APPAREIL
CARDIO-VASCULAIRE

Diapositive 3

LE

POULS

Diapositive 4

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant de la 1

ère

AC doit pouvoir acquérir des connaissances

théoriques sur

le Pouls.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Au terme de ce cours, l'étudiant de la 1

ère

AC doit être capable :

de définir le Pouls conformément à l'enseignement reçu ;

de citer au moins deux sites de prise de Pouls au niveau du membre supérieur et au niveau du membre inférieur ;

d'expliquer les variations physiologiques et pathologiques du Pouls ;

de citer le matériel nécessaire à la prise du Pouls

de décrire sans se tromper, la technique de prise du Pouls.

Diapositive 5

I. DEFINITION

Le Pouls est la sensation de soulèvement perçue par les doigts qui dépriment une artère superficielle sur un plan osseux.

C'est la perception tactile d'une onde transmise dans un milieu liquide (le sang) ; cette onde étant déclenchée par les contractions du ventricule gauche et transmise tout le long du système artériel.

Intérêt

:

existence des contractions du cœur (existence d'une activité cardiaque),

force, amplitude des contractions du cœur,

rythme, fréquence des contractions du cœur.

Diapositive 6

DIFFERENTS SITES DU POULS

-

Au Niveau du Membre Supérieur

Artère radiale (au poignet, sur le prolongement du pouce)

Artère humérale (au pli du coude ou à la face interne du bras)

-

Au Niveau du Membre Inférieur

Artère fémorale (au pli de l'aîne)

Artère poplitée (derrière le genou)

Artère pédieuse (au dessus du pied)

Diapositive 7

DIFFERENTS SITES DU
POULS (suite)

-

Au Niveau de la Face et du Cou

Artère temporale (à la tempe)

La Carotide externe (devant l'oreille)

La Carotide interne (en avant du cou)

- Au Niveau de l'Aorte

Le Pouls est perçu sous la paroi abdominale, au niveau du nombril.

Diapositive 8

SHEMA DU SYSTÈME ARTERIEL

Diapositive 9

LES VARIATIONS DU

POULS

I.

LES VARIATIONS PHYSIOLOGIQUES

1. Selon

l'Age :

Fœtus TM“ 140 à 160 pulsations/Min

A la naissance TM“ 3 c VÇ6 F–öç2ôÖ–à

A 4 mois TM“ 3 VÇ6 F–öç2ôÖ–à

A un an TM“ 3 VÇ6 F–öç2ôÖ–à

A 5 ans TM“ VÇ6 F–öç2ôÖ–à

A 14 ans TM“ f f_R VÇ6 F–öç2ôÖ–à

Adulte TM“ 60 à 80 pulsations/Min

Vieillard TM“ c s VÇ6 F–öç2ôÖ–à

Diapositive 10

LES VARIATIONS DU POULS

2. Selon l'Emotion

Toute émotion physique ou morale, provoque une accélération du rythme cardiaque ou parfois un ralentissement du rythme.

3. Selon

l'Effort

Tout effort entraîne une accélération du rythme qui correspond à l'accélération des contractions cardiaques

.

Diapositive 11

LES VARIATIONS DU POULS

II.

Les Variations Pathologiques

Les variations du Pouls reflètent l'état du cœur. Elles sont en rapport avec la vitesse, la fréquence et l'amplitude cardiaque.

1. Variation selon la vitesse

Le Pouls peut être accéléré ; on parle de tachycardie. Elle se rencontre dans les affections cardiaques, les états fébriles et les intoxications.

Le Pouls peut être ralenti ; on parle de bradycardie. Elle se rencontre dans les affections cardiaques et peut être provoquée par la prise de certains médicaments (la Digitaline).

Diapositive 12

2. Variation

selon la fréquence

L'Arythmie :

ce sont des pulsations irrégulières et de forces inégales. Lorsque le rythme est rapide, on dit qu'il y a tachyarythmie ; et lorsqu'il est lent, c'est une bradyarythmie

.

Pouls Alternant :

c'est une succession rythmée de pulsations normales et d'une pulsation faible.

Pouls Intermittent :

c'est une interruption temporaire des pulsations

.

LES VARIATIONS DU POULS (suite)

Diapositive 13

3

. Variation

selon l'amplitude

Pouls Filiforme :

c'est un pouls petit et rapide, donnant aux doigts la sensation d'un fil

.

Pouls

Dicrote :

c'est un pouls donnant deux pulsations pour une contraction cardiaque.

Pouls Bondissant :

c'est la perception d'un soulèvement brusque et intense.

LES VARIATIONS DU POULS (suite)

Diapositive 14

LA PRISE DU POULS

Diapositive 15

Le Matériel

Une montre avec trotteuse

Un stylo rouge

Une feuille de température ou de surveillance ou le carnet de suivi du malade

Diapositive 16

La Technique

La Préparation

Psychologique

Accueillir le malade

Installer le malade

Identifier le malade

Le mettre au repos

Se présenter à lui

L'informer du soin

Lui expliquer le soin

Le rassurer de son innocuité

Diapositive 17

Requérir son adhésion

Réunir le matériel

Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire

Informé le malade de l'imminence du soin

Se laver les mains à l'eau et au savon

Installer le malade confortablement en décubitus dorsal, les bras sur le plan du lit et le poignet légèrement plié.

Prendre le poignet et placer la pulpe de l'index, le majeur et l'annulaire

sur l'artère radiale située sur la ligne de projection du pouce.

Maintenir une légère pression sur l'artère pendant une minute

.

La Technique

(suite)

Diapositive 18

Technique

(suite)

Commencer

à compter une fois que le Pouls est bien perçu, pendant une pendant une minute

.

Informez le malade du résultat et au besoin faites la CCC en rapport avec le soin.

Consignez le résultat sur la feuille de température ou autre document du patient.

Remerciez le malade pour sa collaboration et prenez congé de lui avec des mots gentils.

Diapositive 19

LA TENSION ARTERIELLE

Diapositive 20

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant de la 1

ère

AC doit pouvoir acquérir des connaissances relatives à la Tension Artérielle.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Au terme de ce cours, l'étudiant de la 1

ère

AC doit être capable :

d'expliquer à partir du cours les notions générales de la Tension Artérielle ;

de définir en ses propres termes sans en altérer le sens, l'Hypertension Artérielle et l'Hypotension Artérielle ;

d'énumérer

tous

les facteurs influant sur la Tension Artérielle;

de décrire oralement ou par écrit les conditions et la technique de la prise de la Tension Artérielle

Diapositive 21

DEFINITION – GENERALITES

- La Tension Artérielle est une des données essentielles à l'exploration de l'Appareil Cardiovasculaire.
- La mesure ou la prise de la Tension Artérielle renseigne sur l'état du système cardiovasculaire.
- La Tension Artérielle est la pression sous laquelle le sang circule dans les artères. Elle est fonction de la force de contraction du cœur, de la masse sanguine et de la résistance des vaisseaux.

Diapositive 22

DEFINITION – GENERALITES

La Tension Artérielle se caractérise par deux normes :

La Tension Maxima ou Systolique, qui correspond à la contraction ventriculaire.

La Tension Minima ou Diastolique, qui traduit la résistance des vaisseaux au moment de la diastole ventriculaire.

- L'écart entre la Tension Maxima et la Minima est appelé la Tension Différentielle.

- L'unité de mesure de la Tension Artérielle est le centimètre de mercure ou le millimètre de mercure (cmHg

ou

mmHg

). Dans les conditions normales,

la Tension Minima = (Tension Maxima / 2) + 1

Ex : si Max = 12, Min = 12 / 2 + 1 = 7

Diapositive 23

On

distingue deux types de
variation:

l'Hypertension Artérielle

l'Hypotension

Artérielle.

LES VARIATIONS DE LA TENSION ARTERIELLE

Diapositive 24

Hypertension Artérielle

On dit qu'il y a Hypertension Artérielle lorsque la Tension Maxima est supérieur 160mmHg et que la Tension Minima est supérieur à 90mmHg.

Elle se rencontre dans les Néphrites, l'Artériosclérose, le Diabète, la Ménopause

Diapositive 25

Hypotension Artérielle

L'Hypotension

Artérielle correspond à une Tension Maxima inférieur à 100mmHg.

Elle

se rencontre dans les états de Choc, les Maladies infectieuses, la Maladie d'Addison, les Anémies, les Maladies

cachectisantes

Diapositive 26

LES FACTEURS INFLUANT SUR LA TENSION ARTERIELLE

1. -

L'Age

Chez les enfants, la Tension Artérielle est fonction de la taille et de la masse.

Chez l'adulte d'âge moyen en santé, la Tension Artérielle est

= 120 / 70

mmHg

Chez l'adulte, la Tension Artérielle tend à augmenter avec l'âge :

(120 – 160 / 80 – 90

mmHg

)

2.

-

Le Sexe

A partir de l'adolescence, la Tension Artérielle est plus élevée chez l'homme que chez la femme à cause des hormones ; mais quand la femme atteint la ménopause, sa Tension Artérielle est plus élevée que chez l'homme du même âge.

Diapositive 27

3.

-

Les Emotions (le Stress)

L'Anxiété, la Peur, la Douleur, la Joie, etc., provoquent une stimulation sympathique qui fait monter la Pression Artérielle.

4. -

Les Variations Journalières

La Tension Artérielle varie tout au long de la journée ; en général la Tension Artérielle est plus faible le matin ; elle augmente ensuite graduellement au cours de la matinée et de l'après midi, et atteint son maximum dans la soirée.

Diapositive 28

-

Les Médicaments

Certains médicaments peuvent influencer directement ou indirectement sur la Pression Artérielle : ce sont les antihypertenseurs, les analgésiques narcotiques.

-

Les Aliments

Le régime

hypersodé

entraîne une augmentation de la masse liquidienne ; ce qui provoque une élévation de la Tension Artérielle. Par contre un régime hyposodé entraîne une fuite liquidienne donc une baisse de la Tension Artérielle.

Diapositive 29

PRISE DE LA TENSION ARTERIELLE

1

. -

Règles Générales

Le sujet doit être de préférence à jeun

Au repos couché ou assis depuis plusieurs minutes (au moins 10mn)

Il doit être au calme

A distance d'une prise d'excitant (tabac, café, thé...)

Chez un malade, prendre la Tension Artérielle toujours à la même heure et avec le même appareil.

Diapositive 30

2.-

Le

Matériel

Un appareil de Vaquez comprenant un brassard gonflable, une poire pour gonfler le brassard et un manomètre (le Sphygmomanomètre)

Un stéthoscope

Un stylo de couleur rouge

Une feuille de température ou de surveillance ou tout autre document du malade

Diapositive 31

La Technique

Accueillir le client

Identifier le client

Le mettre au repos

Se présenter à lui

L'informer du soin

Lui expliquer le but et le procédé du soin

Le rassurer de son innocuité

Requérir son adhésion

Demander au client s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire

Réunir le matériel

Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool

Diapositive 32

Informez le client de l'imminence du soin

Installez le client en décubitus dorsal ou assis, au repos depuis au moins 10mn

Le client doit éviter tout effort et s'abstenir de fumer au moins 30mn avant la prise

Dénudez le bras en retirant tout vêtement gênant

Tenez le bras au niveau du plan du cœur si le client est assis

Recherchez et palpez l'artère brachiale

Placez le brassard sur le bras à 2,5cm au-dessus du siège de la pulsation de l'artère brachiale

Diapositive 33

Placer le manomètre à la verticale au niveau des yeux

Placer la membrane du stéthoscope sur l'artère brachiale

Fermer la soupape de la poire et gonfler le brassard jusqu'à 30mmHg au dessus de la normale

Ouvrir lentement la soupape pour permettre à l'aiguille ou au mercure de descendre lentement

Diapositive 34

Noter la valeur indiquée sur le manomètre lors du premier bruit clairement entendu

Continuer de dégonfler le brassard et noter la valeur du manomètre qui correspond au silence

Dégonfler complètement le brassard

Réinstaller le client

Lui communiquer la Pression

Se laver les mains

Consigner le soin sur la feuille de température ou de surveillance

Faire au besoin la CCC en rapport avec le soin

Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils

Nettoyer et ranger le matériel

Diapositive 35

COLLAPSUS
CARDIOVASCULAIRE
ET
CHOC

Diapositive 36

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant de la 1

ère

AC doit pouvoir acquérir des connaissances relatives au Choc et au Collapsus Cardio-Vasculaire

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Au terme de ce cours, l'étudiant de la 1

ère

AC doit être capable :

de définir selon les termes du cours, le Collapsus Cardio-Vasculaire et le Choc ;

citer au moins deux étiologies d'un Choc Cardiogénique, Hypovolémique, Infectieux, Traumatique et Anaphylactique ;

d'énumérer les signes cardiaques, cutanées, respiratoire, neurologiques et rénaux;

de décrire la conduite à tenir devant un état de

Choc

Diapositive 37

INTRODUCTION

Le CCV et le Choc sont des manifestations couramment rencontrées chez les patients atteints d'affections cardiovasculaires. Ils constituent une urgence en ce sens que la survie du malade dépend de la mise en route immédiate d'un traitement adapté et efficace.

DEFINITION

Le CCV est la baisse de la Tension Artérielle au dessous des chiffres Minima qui permettent la perfusion des organes sans que ceux-ci ne souffrent.

Le Choc est une chute brutale et importante du débit cardiaque avec anoxie tissulaire.

Diapositive 38

ETIOLOGIE

1. Choc Cardiogénique

Infarctus

du Myocarde

Embolie Pulmonaire

Tamponnade

Péricardique

2. Choc Hypovolémique

Hémorragie

Diarrhée Profuse

Vomissement incoercible

Hypersudation

Diapositive 39

3. Choc Infectieux

Septicémie

Germes à gramme négatif

4. Choc Traumatique

Polytraumatisme

Accident de la Voie Publique

Traumatismes Chirurgicaux et Obstétricaux

5. Choc Anaphylactique

Allergie Médicamenteuse

Allergie Alimentaire

Piqûre d'insecte

Morsure de serpent

Diapositive 40

CLINIQUE

1. Signes Cardiaques

Le Pouls est petit, filant et imprenable

La Tension Artérielle basse avec la Maxima inférieure à 80mmHg

Les veines périphériques sont

collabées

et invisibles

2. Signes Cutanés

Le malade est extrêmement pâle

Il est couvert de sueur froide

Ses extrémités sont froides et cyanosées

Diapositive 41

3. Signes

Respiratoires

Il présente une polypnée superficielle, courte ou parfois ample

Sa respiration est irrégulière

Son nez est pincé (affaissement des ailes du nez)

4. Signes

Neurologiques

Le malade est dans une attitude prostrée

Il est

apathique ou

présente souvent des crises d'agitation

La conscience est conservée

5. Signes

Rénaux

Le malade se plaint de soif intense

Il y a baisse de la diurèse ou une anurie

Diapositive 42

CONDUITE A TENIR DEVANT LE
CHOC

Le rôle de l'infirmier dans la majorité des cas, comporte trois étapes : parer à l'urgence en posant le geste qui sauve, exécuter les consignes et prescriptions médicales enfin, assurer la surveillance

.

Diapositive 43

Le Geste qui sauve

Il faut pouvoir reconnaître l'état de Choc devant l'apparition brusque d'une angoisse, d'une agitation ou au contraire d'une prostration avec les extrémités froides et cyanosées, la sueur, la marbrure, une polypnée superficielle, un pouls petit filant et une tension artérielle effondrée.

Devant ces signes, il faut immédiatement appliquer la loi des 4 tuyaux.

Prendre une voie veineuse et procéder à un bon remplissage vasculaire avec du sang iso groupe, iso rhésus ou des macromolécules

Diapositive 44

Prendre une deuxième voie veineuse pour les injections intraveineuse directe (IVD), de vasopresseur ou de soluté de bicarbonate ;

Oxygéner le malade au masque ou par sonde nasale, à raison de 6 litre / minute ;

Placer une sonde vésicale à demeure

.

Exécution

des Prescriptions Médicales

Ce sont les gestes de diagnostic ou thérapeutiques, conseillés, recommandé par le Médecin ou qui nécessite sa présence :

Prévenir le Médecin dès l'apparition des signes de Choc

Noter l'existence d'une douleur et en informer le Médecin

Préparer un soluté bicarbonaté et un sérum avec des vasopresseurs en attendant les consignes du Médecin

Demander un hématocrite et un groupe rhésus en urgence.

Diapositive 45

La Surveillance

La surveillance doit porter essentiellement sur les entrées, les sorties, le pouls, la tension artérielle et l'état général.

Régler la perfusion du vasopresseur de façon que la pression systolique n'excède pas 120mmHg de Maxima

Régler le débit d'oxygène à 5 ou 6 litre / minute et vérifier la recoloration des extrémités

Régler le débit des solutés

Surveiller la diurèse

Surveiller le pouls, la tension artérielle, l'état général, à tout instant, jusqu'à ce que le malade retrouve son état antérieur.

Diapositive 46

LES INJECTIONS

Diapositive 47

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant de la 1

ère

AC doit pouvoir acquérir des connaissances théoriques relatives aux Injections Médicamenteuses.

OBJECTIFS

SPECIFIQUES

Au terme de ce cours, l'étudiant de la 1

ère

AC doit être capable :

de définir en ses propres termes sans en altérer le sens les injections médicamenteuses ;

d'énumérer tout le matériel nécessaire à une injection ;

de décrire les étapes de la préparation des produits à injecter ;

de décrire à partir du cours la technique relative à chaque type d'injection ;

d'énumérer les accidents et les incidents dus aux injections

.

Diapositive 48

DEFINITION

L'injection médicamenteuse est l'introduction sous pression, à l'aide d'une seringue ou d'un appareil approprié, de produits liquides dans les tissus organiques.

On distingue principalement 4 types d'injection :

L'injection sous-cutanée,

L'injection intramusculaire,

L'injection intraveineuse,

L'injection intradermique.

Diapositive 49

PREPARATION DU SOIN

-

Préparation Psychologique

Elle est indispensable voire obligatoire dans tous les soins. Elle permet de rassurer le malade, de mettre en confiance et d'obtenir son adhésion et sa collaboration au soin :

aller au pied du lit et identifier le malade

le saluer et s'enquérir de son état

le prévenir du soin

lui expliquer le soin

le rassurer de son innocuité

recueillir ses préoccupations

s'enquérir des besoins pressant à soulager

lui annoncer qu'on revient dans quelques instants pour le soin

Diapositive 50

-

Préparation du Matériel

Aller dans la salle de pansement

Se laver les mains et prendre un chariot à pansement

Nettoyer le chariot

Diapositive 51

Installer à l'étage supérieur du chariot

un plateau stérile ou désinfecté

une seringue à usage unique, sous emballage stérile (le nombre des seringues sera fonction des injections à faire)

un trocart sous conditionnement stérile

les substances médicamenteuses

une lime si nécessaire

des tampons de coton

un flacon d'alcool

un garrot, s'il est prévu des injections intraveineuses

une

alèse

Installer à l'étage inférieur

un haricot (ou réniforme) ou une cupule

un bac à ordures

Diapositive 52

-

Préparation de l'injection

se laver les mains et les passer à l'alcool

sortir

la seringue et le trocart de leur emballage

saisir aseptiquement la seringue par le corps ou par le col du piston

saisir l'aiguille en la tenant par l'embout

prévoir une deuxième aiguille en cas d'accident

vérifier l'identité du malade, les doses et le dosage avant de remplir la seringue

Diapositive 53

Si le produit à injecter est liquide

frapper légèrement l'extrémité de l'ampoule avec le doigt ou la lime pour faire descendre le liquide

aseptiser le col de l'ampoule et la lime avec un tampon d'alcool

limer le col de l'ampoule

ouvrir l'ampoule en se protégeant les doigts avec un tampon de coton

tenir l'ampoule entre l'index et le majeur de la main gauche, et la seringue entre le pouce, l'annulaire et l'auriculaire de la main gauche

avec la main droite, saisir le col du piston et tirer lentement ; le liquide passe de l'ampoule dans la seringue

.

Diapositive 54

Si le produit est en poudre

aseptiser le bouchon de caoutchouc à l'aide de tampon d'alcool

y planter un

trocart et prélever

le solvant dans l'ampoule, au moyen de la seringue et l'injecter dans le flacon

agiter le flacon pour obtenir une bonne dilution de la poudre

aspirer de l'air dans la seringue

perforer le bouchon en introduisant seulement l'extrémité du trocart

injecter l'air dans le flacon et maintenir le piston poussé à fond

retourner immédiatement le flacon et libérer le piston

la suspension, sous l'effet de l'air comprimée, passe spontanément dans la seringue

Diapositive 55

TECHNIQUE DE L'INJECTION

La technique est fonction de la voie d'administration

-

Injection Sous Cutanée

Région

d'élection

face externe du bras et de la cuisse

région sus et sous épineuse de l'omoplate

région deltoïdienne

paroi

abdominale

Diapositive 56

La Technique

prévenir le malade de l'imminence du soin

se laver les mains et les passer à l'alcool ou porter des gants stériles

installer confortablement le malade

prendre un tampon d'alcool et aseptiser la peau

prendre la seringue et purger l'air

maintenir avec une main la seringue en position parallèle et tangentielle à la peau

avec l'autre main pincer la peau entre le pouce et l'index pour former un pli cutané

Diapositive 57

piquer franchement à la base du pli obtenu et faire pénétrer assez loin l'aiguille
mobiliser l'aiguille pour vérifier sa position dans les tissus sous cutanées
injecter doucement tout le liquide
déposer et maintenir un tampon de coton à la base de l'aiguille et retirer celle-ci rapidement
obturer l'orifice de la piqûre en tamponnant avec le coton alcoolisé
réinstaller le malade
remercier le malade pour sa collaboration et prendre congé de lui avec des mots gentils
nettoyer et ranger le matériel

Diapositive 58

-

Injection Intra

Musculaire

Région

d'élection

L'injection doit se faire dans le quart supérieur et externe de la fesse, pour éviter de piquer dans le nerf sciatique et des gros vaisseaux. Il faut donc délimiter la région par deux lignes, la première allant du grand trochanter au sommet du pli inter fessier et la seconde, croisant la première en son milieu et perpendiculairement.

L'injection peut se faire dans la zone sus épineuse de l'omoplate, chez les brûlés, les plâtrés, les cardiaques

œdémateux.

L'injection peut également se faire au tiers moyen de la face antéro-externe de la cuisse

.

Diapositive 59

La Technique

Laver les mains, les passer à l'alcool ou porter des gants stériles

Installer confortablement le malade, en position assise ou en décubitus latéral ou ventral

Délimiter la zone à injecter (quart supérieur et externe de la fesse)

Aseptiser la peau

Tendre la peau avec le pouce et l'index ou le majeur de la main gauche

Avec la main droite tenir la seringue perpendiculairement à la peau

et

p

iquer et enfoncer rapidement l'aiguille dans toute sa longueur (on peut piquer l'aiguille séparée de la seringue)

Diapositive 60

Aspirer

pour vérifier que l'on ne se trouve pas dans un vaisseau sanguin

Injecter le liquide lentement et totalement

Poser et maintenir un tampon d'alcool à la base de l'aiguille et retirer celle-ci rapidement

Obturer l'orifice de la piqûre en tamponnant avec le coton alcoolisé

Réinstaller le malade

Le remercier de sa collaboration et prendre congé de lui avec des mots

gentils

NB

:

Si

l'aiguille heurte un os, retirer légèrement celle-ci et injecter le

produit

.

Si

l'aspiration ramène du sang dans la seringue,

enlever

l'aiguille

et

piquer

dans un autre

endroit

Diapositive 61

-

Injection Intra Veineuse

Région d'élection

Veine de la région du pli du coude

La Technique

Se laver les mains et les passer à l'alcool ou porter des gants stériles

Prévenir le malade de l'imminence du soin

Installer confortablement le malade

Placer le garrot, ne pas trop serrer, le pouls doit rester perceptible

Diapositive 62

Aseptiser

la peau au niveau du pli du
coude

Tenir

le bras à pleine main

Mettre le bras en extension

Saisir la seringue en maintenant le biseau de l'aiguille tourné vers le haut

Repérer la veine

Empaumer

le coude, tendre la peau et immobiliser la veine avec le pouce

Appuyer l'aiguille au centre de la veine

Perforer la peau et la veine en angle aigu

Diapositive 63

Mettre alors l'aiguille en position tangentielle à la peau et pousser l'aiguille d'un à deux centimètre

Aspirer ; le sang doit arriver dans la seringue

Enlever le garrot

Pousser le liquide très lentement dans la veine

Aspirer le sang de temps en temps pour vérifier que l'aiguille est toujours dans la veine

Vérifier les réactions du malade

Lorsque l'injection est terminée, poser et maintenir un tampon

Diapositive 64

d'alcool

à la base de l'aiguille et retirer celle-ci

Maintenir la pression sur la veine pendant quelques instants, pour éviter l'écoulement du sang

Remercier le malade pour sa collaboration et prendre congé de lui avec des mots gentils

Nettoyer et ranger le matériel

Diapositive 65

-

Injection Intra Dermique

Région

d'élection

Face externe et interne de l'avant bras

Face externe et interne du bras

Face externe et interne de la cuisse

Au niveau de toute les régions douloureuse, pour les thérapeutiques analgésiques

Diapositive 66

La Technique

Informer le malade de l'imminence du soin

Installer confortablement le malade

Se laver les mains et les passer à l'alcool

Repérer la zone d'injection et aseptiser la peau

Tenir le bras à pleine main et tendre la peau

Saisir la seringue avec l'autre main

Introduire l'aiguille tangentiellement à la peau

Diapositive 67

La

Technique (suite)

Dès

que le biseau a disparu, pousser doucement le produit

Le volume injecté doit produire une petite boule d'œdème blanc

Retirer l'aiguille et mettre un tampon de coton à l'endroit de l'injection

Remercier le malade et prendre congé de lui avec des mots gentils

Nettoyer et ranger le matériel.

Diapositive 68

INCIDENTS ET ACCIDENTS DUS AUX INJECTIONS

L'injection médicamenteuse, quelque soit son type, n'est pas toujours sans dangers pour le patient et pour le personnel soignant. L'infirmier est responsable des accidents pouvant survenir par erreur ou par négligence.

Les accidents ou incidents pouvant survenir au cours ou à l'issus d'une injection sont :

Diapositive 69

Erreurs

Médicamenteuses

Il faut toujours vérifier avant l'injection :

la dose de produit prescrit

le dosage de l'ampoule

le nom du malade

la voie d'injection de l'ampoule

préparer toujours l'injection au pied du lit

Les

Abcès

L'abcès survient :

par manque d'asepsie

par une mauvaise résorption du produit

Diapositive 70

"ÆW2 W66 '&W0

L'escarre survient par erreur de voie d'introduction pour certains produits (ne jamais injecter les solutés hypertoniques en S/C ou en IM mais toujours en IVD

)

Rupture de l'aiguille dans les tissus

Piqûre dans un vaisseau

Douleurs au point d'injection

Diapositive 71

Pour éviter la douleur, il faut :

bien délimiter le lieu d'injection

introduire l'aiguille d'un coup rapide

injecter lentement

prendre une seringue non émoussée

La Contamination par la seringue

Pour éviter la contamination par la seringue, prescrire des seringues individuelles ou à usage unique.

Diapositive 72

LES HEMORRAGIES

Diapositive 73

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant de la 1

ère

AC doit pouvoir acquérir des connaissances sur les Hémorragies.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Au terme de ce cours, l'étudiant de la 1

ère

AC doit être capable :

de définir l'hémorragie conformément à l'enseignement reçu ;

d'énumérer les causes d'une hémorragie ;

d'expliquer les signes d'une hémorragie ;

d'expliquer la conduite à tenir devant une hémorragie ;

Diapositive 74

I

—

DEFINITION

Une hémorragie est un écoulement de sang hors des cavités vasculaires. L'hémorragie peut être interne ou externe et, selon la localisation, elle peut être artérielle veineuse ou capillaire.

Diapositive 75

II –

ETIOLOGIE

Hémorragie de cause traumatique

- Hémorragie

primitive, qui survient aussitôt après le traumatisme

- Hémorragie

secondaire, celle qui apparaît plusieurs heures ou des jours après le traumatisme.

Trouble de la coagulation sanguine

- Hémophilies

Maladie de l'appareil circulatoire

- Hypertension

Artérielle

Lésion

organique

- Ulcère de l'estomac

Diapositive 76

III -

LES SIGNES

—

Signes locaux

Hémorragie Externe

- On

parle d'hémorragie externe lorsqu'il y a ouverture cutanée et que le sang s'écoule à l'extérieur de l'organisme. Les signes diffèrent en fonction des vaisseaux lésés.

- Hémorragie

Artérielle : c'est un écoulement de sang rouge vif, en jets saccadés et rythmé sur les pulsations.

-

Hémorragie

Veineuse : c'est un faible écoulement de sang foncé, continu sans saccades.

- Hémorragie

Capillaire : c'est un écoulement de sang en nappe, en surface (raclage d'un bras contre le mur).

Diapositive 77

Hémorragie Interne

- On

parle d'hémorragie interne lorsque le sang se répand dans les tissus ou dans une cavité close de l'organisme (rate, thorax, abdomen, crâne, estomac, ...)

- L'hémorragie

interne peut s'extérioriser ; elle est alors décelée par l'écoulement de sang à l'extérieur de l'organisme, et diagnostiqué par son caractère propre : hémoptysie, hématomèse, métrorragie, ...

- L'hémorragie

interne peut ne pas s'extérioriser (rupture de la rate, ou du foie) ; dans ce cas le diagnostic repose sur l'atteinte de l'état général.

Diapositive 78

-

Signes généraux

Ils sont d'autant plus importants que l'hémorragie est abondante et intense :

pâleur du

visage, refroidissement

, sueur froide, hypothermie, frisson

pouls

petit et

filant, tendance

à la

syncope

chute de la tension artérielle, respiration

accélérée et superficielle

soif

ardente et agitations

douleurs vives localisées dans les hémorragies internes.

Les signes généraux d'une hémorragie importante sont ceux du Choc (Hypovolémique).

Diapositive 79

IV – CONDUITE A TENIR

(sur les lieux de l'accident ou en urgence)

–

Hémorragie Artérielle

Deux gestes peuvent s'avérer nécessaires et efficaces : la compression manuelle et la pose de garrot.

Diapositive 80

La Compression Manuelle

Elle se fait au moyen du poing ou des doigts, il faut écraser, comprimer l'artère au dessus de la plaie.
Les points de compression sont les suivants

Artère humérale : la compression se fait au pli du coude, en dedans du tendon du biceps ou au milieu du bras, à la face interne entre le biceps et le triceps.

Artère axillaire : au milieu du creux axillaire, faire une compression énergique de bas en haut.

Artère carotide : la compression se fait sur l'apophyse transverse de la 5

ème

vertèbre cervicale (au niveau du larynx)

Diapositive 81

La Compression

Manuelle (suite)

Artère

abdominale (hémorragie après un accouchement ou un avortement) : écraser l'aorte abdominale, au niveau de l'ombilic, en la comprimant contre la colonne vertébrale (efficace seulement chez le sujet maigre

)

Artère

fémorale : faire la compression au niveau du pli de l'aîne, ou à la face interne de la cuisse, ou dans le creux poplité

.

Diapositive 82

La Pose de Garrot

Le Garrot doit être posé tout en maintenant la compression ; se faire aider si nécessaire. On peut utiliser pour le garrot, un tube élastique, une cravate ou un bas.

poser le garrot en double, en amont de la plaie, le plus près possible de la plaie (jamais sur un avant bras ou en dessous du genou)

tout en maintenant une main sur la compression, passer avec la main libre, les deux chefs dans la boucle formée

prendre un des chefs et maintenir l'autre entre les dents

et

serrer au maximum

Diapositive 83

lâcher à ce moment le point de compression et achever de serrer le garrot

puis

ramener les deux chefs de chaque côté du membre et nouer en faisant un nœud

plat

faire

un pansement stérile sur la plaie et évacuer d'urgence le blessé vers le centre chirurgical le plus proche

inscrire

toujours l'heure de la pose du garrot et l'attacher au pansement ; il y a danger à laisser longtemps un garrot en place car les tissus étant privés de sang, il peut y avoir gangrène

.

NB

:

Le garrot ne doit être utilisé que pour une hémorragie d'une grosse artère ; autrement il est inutile et même

dangereux

Diapositive 84

- Hémorragie Veineuse et Capillaire

Dans ce cas faire un pansement compressif. Vérifier ensuite après le pansement, la chaleur et la couleur du membre, qui ne doit être ni froid, ni cyanosé ; rechercher de même la perception des pulsations ; si elles n'existent pas, il faudrait desserrer légèrement le pansement. Enfin placer le membre en position surélevée.

En cas d'hémorragie par rupture des varices, placer un garrot au dessous de la plaie.

Diapositive 85

-

Hémorragie Interne

L'hémorragie interne constitue une urgence chirurgicale. Seule l'intervention chirurgicale peut arrêter l'hémorragie.

Mettre le blessé la tête basse et l'envelopper dans une couverture sans le réchauffer et l'évacuer d'urgence vers un centre chirurgical qui fera une prise en charge et un traitement adapté et adéquat.

Diapositive 86

LES PERFUSIONS

Diapositive 87

OBJECTIF GENERAL

acquérir

des notions sur les perfusions.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Au terme de ce cours, l'étudiant de la 1

ère

AC doit être capable :

de définir selon le cours, le concept de perfusion ;

d'en énumérer

quatre indications et deux

contre-indications

d'énumérer les différents solutés à perfuser, en indiquant deux exemples de chaque ;

de

décrire

la procédure de préparation

et la technique de

la perfusion;

de

citer tous les accidents et incidents de la perfusion ;

de décrire selon le cours la surveillance d'un malade sous perfusion

.

Diapositive 88

DEFINITION

La perfusion est une injection prolongée, continue ou discontinue, par voie intraveineuse ou sous-cutanée, d'une quantité importante de soluté, contenant ou non des médicaments

Diapositive 89

LES INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

-

Les Indications

Déshydratation aigue

Réanimation hydro électrolytique

Soins pré, per et post-opératoire

Alimentation parentérale intraveineuse chez les comateux, les grands dénutries ou les anorexiques

Diapositive 90

-

Les

Contre-indications

dans les cas d'œdème aigu des poumons (OAP)

Insuffisance cardiaque

Anasarque (œdème généralisé)

Dans les néphropathies sévères

Diapositive 91

LES SOLUTES INJECTABLES

-

Les Solutés Isotoniques

Un soluté est dit isotonique, lorsqu'il a la même pression osmotique que le sérum sanguin

Dans un soluté isotonique, les éléments figurés du sang (hématies, leucocytes, plaquettes...) peuvent se maintenir sans modification sensible de leurs propriétés et de leur forme

.

Exemples de solutés isotoniques :

sérum glucosé isotonique (SGI) à 5%

sérum salé ou sérum physiologique à 0,9%

sérum bicarbonaté à 1,4%

Diapositive 92

-

Les Solutés Hypertoniques

Un soluté est dit hypertonique lorsque sa pression osmotique est plus élevée que celle du plasma sanguin.

Exemples de solutés hypertoniques :

sérum glucosé à 10%

sérum glucosé à 30%

NB

:

Un soluté hypertonique ne doit jamais être utilisé par voie hypodermique, mais exclusivement par voie intraveineuse. La forte concentration provoque de vastes escarres au point d'injection, par suite de déshydratation extracellulaire localisée.

Diapositive 93

-

Les Solutés à grosses molécules

Ce sont des solutés qui sont utilisés à la place du sang, dans les hémorragies intenses, dans les états de Choc ou en cas de dénutrition grave.

Exemples de solutés à grosses molécules :

Géloplasma

Ringer

lactate

Nutrilamine

Plasmacaire

Rhéomacrodex

Diapositive 94

LA TECHNIQUE DE LA PERFUSION

-

Le Matériel

Prendre un chariot à pansement

un plateau stérile si possible

des tampons de coton

un flacon d'alcool

une seringue

une épicrotine

un garrot

les solutés à perfuser

Diapositive 95

une potence

une montre avec trotteuse

du sparadrap

des compresses

une paire de gants

une alèse

un haricot

un bac à ordure

Diapositive 96

-

Préparation du Médicament

Certaines substances peuvent être perfusées directement ; ce sont : le

Flagyl

, le

Ringer

, le

Géloplasma

etc. d'autres par contre demandent une préparation, lorsqu'il est nécessaire d'ajouter au soluté certains produits tels : les Antibiotiques, les Antipaludiques, les Vitamines Etc

.

Diapositive 97

Procédure de la préparation

Réunir le matériel nécessaire et indispensable au soin

Aller au lit du malade

Se laver les mains et les passer à l'alcool ou porter les gants

Flamber le plateau s'il n'a pas été stérilisé, et le laisser refroidir

Sortir la seringue de son emballage et la déposer dans le plateau

Déposer quelques tampons d'alcool dans le plateau

Désinfecter la surface externe du bouchon du soluté

Prélever les différents médicaments dans une seringue et les ajouter au soluté

Inscrire sur l'étiquette du flacon, le nom des produits ajoutés

Diapositive 98

Sortir le perfuseur de son emballage et le déposer dans le plateau

Fermer le raccord avec le presse-tube

Aseptiser de nouveau le bouchon du flacon

Adapter le perfuseur au flacon de soluté

Suspendre le soluté sur la potence ou le pied à sérum

Comprimer la chambre compte gouttes et relâcher pour la remplir à la moitié ou au deux tiers (2/3)

Ouvrir doucement le presse-tube pour laisser couler le soluté

Chasser complètement l'air dans la tubulure ; il ne doit pas y avoir de bulle d'air

Informez le malade de l'imminence du soin

Placer la perfusion selon la technique propre à chaque voie d'injection.

Diapositive 99

Les Différents types de Perfusion

La Perfusion sous-cutanée

Région d'é

I

ection

face externe de la cuisse

côté gauche de la paroi abdominale

au niveau de la grille costale

Diapositive 100

Procédure

installer confortablement le malade en décubitus dorsal

placer l'alèse sous le malade, du côté de l'opérant

identifier la région d'injection et aseptiser la peau

introduire l'aiguille montée sur la seringue comme pour une injection sous cutanée

mobiliser l'aiguille pour vérifier sa position dans les tissus sous cutanés

désinsérer

l'aiguille de la seringue et l'adapter à la tubulure ou perfuseur

Diapositive 101

Procédure (suite)

recouvrir

d'une compresse pliée en deux

ouvrir le presse tube pour permettre l'écoulement du soluté

maintenir le perfuseur à la peau à l'aide d'une bande adhésive ou sparadrap

régler le débit

noter le soin

remercier le malade pour sa collaboration et prendre congé de lui

nettoyer et ranger le

matériel

Diapositive 102

-

La Perfusion Intraveineuse simple

Région d'élection

Les veines du pli du coude

les veines de l'avant bras

les veines du dos de la main

les veines du pied

les veines du crâne

Diapositive 103

Procédure

informer le malade de l'imminence du soin

laver les mains et les passer à l'alcool ou porter des gants

installer confortablement le malade en décubitus dorsal

sortir l'épicrânienne de son emballage (s'il y en a)

purger l'épicrânienne

placer l'alèse sous le bras le plus accessible et recouvrir l'hémi thorax du même côté

placer le garrot sur le bras ou l'avant bras, selon le site que l'on se propose de choisir

repérer la veine à ponctionner ; choisir une grosse veine

aseptiser la peau

Diapositive 104

Procédure (suite)

empaumer

le bras, tendre la peau et immobiliser la veine avec le pouce

piquer la veine en son centre avec l'aiguille de l'épicrânienne

enfoncer l'aiguille dans toute sa longueur

ouvrir le bouchon de l'embout de l'épicrânienne

le sang doit remonter dans la tubulure de l'épicrânienne

adapter alors le perfuseur à l'épicrânienne puis desserrer le garrot

ouvrir le presse-tube et regarder le soluté s'écouler dans le compte

gouttes

Diapositive 105

Procédure (suite et fin)

immobiliser

l'épicrânienne et la tubulure avec une bande adhésive

régler le débit de la perfusion

enlever l'alèse et le garrot

réinstaller le malade

se laver les mains

noter le soin

remercier le malade de sa collaboration et prendre congé de lui avec des mots gentils

nettoyer et ranger le matériel

Diapositive 106

1ml = 20gttes

Débit (ou nombre de gouttes/mn) = $\frac{\text{quantité de soluté en ml} \times 20 \text{ gttes}}{\text{Temps en mn}}$

Exemple :

Passer 500ml de soluté en 4heures

Débit = 500×20

=

' B , c TM 240

Débit' Ò C" wGFW2 ò Öà

Calcul du débit

Diapositive 107

LES ACCIDENTS ET INCIDENTS

-

Au Plan Local

1. Gonflement

ou Œdème du membre

Il se produit au point d'injection ; le liquide passe en dehors de la veine.

Conduite à tenir :

enlever la perfusion et la replacer ailleurs

faire un pansement alcoolisé au niveau de l'
oedème

Diapositive 108

2. Hématome

Il s'agit d'un épanchement de sang autour du point d'injection ; il se voit chez le sujet ayant une fragilité capillaire et des troubles de la coagulation. Cliniquement, le sujet ressent une douleur au niveau de l'hématome.

Conduite à tenir :

Faire

un pansement alcoolisé sur

l'hématome

Diapositive 109

3. Lymphangite

Elle se traduit par une traînée rouge et douloureuse le long du membre et une augmentation de la température ; elle est due à une faute d'asepsie

Conduite à tenir :

Changement d'emplacement de la perfusion

Faire un pansement chaud et alcoolisé

Faire une antibiothérapie

Diapositive 110

4. Sclérose

de la veine

Elle est due à l'irritation de la paroi interne de la veine. Cliniquement le malade ressent une douleur sur le trajet de la veine et le soluté passe difficilement.

Conduite à tenir :

- Changer très souvent le lieu de l'injection, si la perfusion doit être maintenue pendant plusieurs jours

Diapositive 111

5. Escarres

L'escarre se voit lorsque le soluté passe dans les tissus sous cutanés (uniquement avec les solutés hypertoniques). Cliniquement on a une nécrose locale des tissus.

Conduite à tenir :

Faire la perfusion avec un cathéter veineux ou intranule, ou bien surveiller la perfusion s'il s'agit d'un soluté hypertonique.

Diapositive 112

6. Interruption

des gouttes

Vérifier la position de l'aiguille, la faire bouger légèrement, la tourner ou la soulever et faire glisser un petit bout de coton sous l'embout. Si l'aiguille est bouchée, la changer et recommencer la pose de la perfusion.

7. Le

liquide coule sur le bras

Il s'agit probablement d'une mauvaise adaptation de l'aiguille et de l'embout, ou d'une injection trop rapide de

soluté

Diapositive 113

-

Au Plan Général

Les Céphalées et les Nausées

Il faut ralentir le débit et surveiller le malade ; si les troubles persistent ou s'aggravent, arrêter la perfusion.

La Septicémie

Elle est due à une faute d'asepsie. Il faudrait donc appliquer une asepsie rigoureuse à toutes les étapes de la technique de la perfusion.

Le Choc ou

shock

Devant l'apparition de la sueur, la pâleur du visage, l'agitation, les frissons, une soif intense, il faut arrêter la perfusion

et administrer des corticoïdes et faire si possible une oxygénothérapie.

Diapositive 114

LA TRANSFUSION SANGUINE

Diapositive 115

OBJECTIF GENERAL

acquérir

des notions sur la transfusion sanguine.

OBJECTIFS

SPECIFIQUES:

être

capable

de:

définir

selon le cours, la transfusion

sanguine

énumérer

les indications et contre-indications de la

transfusion

indiquer

les précautions à prendre dans le transport du sang, dans la préparation et lors de la transfusion;

citer le

matériel courant, le matériel de protection et le matériel spécifique de la transfusion;

décrire

la technique de la transfusion sanguine;

de citer tous les accidents et incidents de la transfusion sanguine.

Diapositive 116

DEFINITION

La transfusion consiste à faire passer du sang iso groupe iso rhésus, (ou de ses dérivés : plasma, sérum), d'un sujet appelé "donneur", directement dans la circulation veineuse d'un autre sujet appelé "récepteur" ou "receveur".

Diapositive 117

LES INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

-

Les Indications de la transfusion

les anémies sévères

l'état de choc

actions de remplissage en remplacement du sang perdu

action hémostatique

action

anti-anémique

, anti-infectieux et

anti-toxique

-

Les contres indications

Les contre indications sont ceux de la perfusion.

Diapositive 118

PRECAUTIONS A PRENDRE

-

Dans le Transport

Le sang ne doit pas rester longtemps hors du réfrigérateur ; il faudra aller le chercher au dernier moment

Ne jamais commander un flacon de sang par téléphone, mais aller à la banque de sang avec un bon et la carte de groupe sanguin et facteur rhésus du malade.

Ne pas secouer le sang lors du transport ; penser que c'est un liquide fragile

Assurer le transport dans une glacière

Diapositive 119

-

Dans la Préparation

Utiliser toujours du sang iso groupe, iso rhésus

Vérifier la date limite d'utilisation (pas plus de 10 jours) et surtout le groupe et le facteur rhésus

Ne pas réchauffer le sang, mais le laisser à la température ambiante

Si le sang ne doit pas être utilisé immédiatement, le conserver dans une glacière à température de +4°C

Diapositive 120

- Lors de la transfusion

Revérifier juste avant la pose, l'étiquette du flacon et la carte du groupe sanguin du malade

Faire couler le sang lentement, à raison de 10 à 30 gouttes à la minute. Ne jamais faire passer simultanément ou successivement, du sang et un soluté glucosé, ce qui aurait pour conséquence de provoquer une hémolyse des globules rouges

Surveiller de près la transfusion et arrêter celle-ci immédiatement au moindre frisson ou signe de Choc

Diapositive 121

LE MATERIEL

-

Le Matériel Courant

un chariot

un haricot

un grand plateau propre et un petit plateau stérile

une boîte d'allumettes

un savon

une serviette

Diapositive 122

- Matériel d'asepsie et de Protection
- alcool à 90° ou l'alcool iodé
- des compresses stériles
- du coton
- une alèse
- une paire de gants stériles

Diapositive 123

-

Le Matériel Spécifique

un garrot

un transfuseur sous conditionnement stérile

du sparadrap

un flacon de sang ou son dérivé à transfuser

une potence

un cathéter veineux ou intranule

une montre avec trotteuse

une paire de ciseaux

Diapositive 124

LA TECHNIQUE

-

Préparation de la Transfusion

La préparation doit se faire au lit du malade

se

laver les mains à l'eau et au

savon

les

mains à l'alcool ou porter des

gants

flamber

le plateau s'il n'est pas stérile, et le laisser

refroidir

sortir

le transfuseur de son emballage et le déposer dans le plateau

stérile

aseptiser

l'embout du flacon de

sang

fermer

le raccord avec le presse tube

Diapositive 125

piquer franchement dans l'embout du flacon de sang avec la fiche perforante

suspendre le flacon sur la potence

comprimer

la chambre compte gouttes pour la remplir à la moitié ou au 2/3 (le filtre doit être complètement noyé)

ouvrir doucement le presse tube pour laisser couler le sang ; chasser ainsi l'air du raccord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule bulle d'air

fermer le raccord avec le presse tube

remettre le capuchon protecteur du trocart

Diapositive 126

Pose

de la

Transfusion

informer

le malade de l'imminence du soin

installer le malade confortablement en décubitus dorsal

faire le test de compatibilité

se désinfecter à nouveau les mains à l'alcool

mettre l'alèse ou la toile de protection sous le bras du malade

poser le garrot sur le bras

repérer la veine à ponctionner et désinfecter soigneusement la région (choisir une grosse veine)

Diapositive 127

empaumer le bras, tendre la peau et immobiliser la veine avec le pouce

piquer au milieu de la veine et enfoncer l'aiguille ou l'

intranule

dans toute sa longueur

immobiliser l'aiguille ou l'

intranule

avec une bande adhésive ou du sparadrap

ôter le garrot

ouvrir le presse tube pour faire couler le sang

maintenir le raccord du transfuseur par du sparadrap

retirer l'alèse

noter le soin sur une feuille de température

remercier le malade pour sa collaboration et prendre congé de lui avec des mots gentils

nettoyer et ranger le matériel

Diapositive 128

LES ACCIDENTS ET
INCIDENTS

-

Les Accidents

Accidents Précoces

le Choc (hypovolémique ou anaphylactique)

l'allergie

l'hémolyse

la

fièvre

Accidents

de Surcharge

œdème aigue des poumons (OAP)

Diapositive 129

Accidents Tardives

Formation de caillot de sang

embolie pulmonaire

infection

nosocomiale

(paludisme, syphilis, hépatite virale)

-

Les Incidents

perforation de la veine

rupture du cathéter

Diapositive 130

LA

SURVEILLANCE

Surveillance

du Matériel de

Transfusion

vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau du raccord

vérifier que l'aiguille est toujours en place dans la veine

vérifier si la chambre compte gouttes marche bien

vérifier le débit de la transfusion

Diapositive 131

Calcul du Débit

1ml

de sang = 15 gouttes

Débit

= (

15 gttes x

qtté

à transfuser)

TM Temps

en

mn

Exemple

: Calculer le débit de la transfusion, pour 500ml de sang à transfuser en 2 heures

TM 15 x 500 = 63

gttes

TM 2X60

Diapositive 132

-

Surveillance du malade

observer le faciès pour détecter une éventuelle congestion

observer le thorax pour voir s'il respire bien

vérifier les constantes

vérifier le point de transfusion et la veine transfusée

il faut tenir compte des plaintes du malade (céphalées, douleurs lombaires, frissons)

NB

:

Au moindre signe d'alerte, arrêter immédiatement la transfusion et avertir le Médecin

Diapositive 133

PRINCIPAUX SIGNES D'ATTEINTE DE L'APPAREIL
CARDIO-VASCULAIRE

Diapositive 134

INTRODUCTION

L'organisme se compose de plusieurs appareils ; l'atteinte de chacun de ces appareils va se manifester par des symptômes ou syndrome qui seront soit ressentis par le malade, soit retrouvés lors de l'examen clinique, ou mis en évidence par des examens paracliniques. Nous nous intéresserons dans ce cours des principaux symptômes ou syndrome ressentis par le malade atteint d'affections cardio-vasculaires.

Diapositive 135

LA DYSPNEE

La Dyspnée est une difficulté respiratoire ou une modification de la respiration. Elle peut se manifester par l'accélération du rythme respiratoire (polypnée) ou par un ralentissement du rythme (bradypnée).

Les dyspnées d'origine cardiaque sont provoquées par l'effort ou la position allongée, et elles sont soulagées par le repos ou la position assise.

Fréquemment la dyspnée va s'accompagner de cyanose et de sueur qui sont signes de gravité car traduisent le manque d'oxygène.

Diapositive 136

LA TOUX ET L'EXPECTORATION

Dans les toux d'origine cardiaque, contrairement aux maladies pulmonaires, il n'y a pas de soulagement du patient qui est fatigué par la toux et l'expectoration.

L'expectoration peut prendre plusieurs formes

:

Crachat muqueux

Crachat

mousseux et hémoptoïque (Œdème Aigu des
Poumons)

Crachat

sanglant ou hémoptysie (Embolie Pulmonaire)

Diapositive 137

LES DOULEURS THORACIQUES

La douleur est caractérisée par son siège, son intensité, son horaire, son mode de déclenchement, sa durée, ses irradiations et les signes associés

.

Trois types de douleurs sont en rapport avec une atteinte cardiaque

La

Douleur Ischémique ou

Coronarienne

C'est une douleur liée à l'effort, qui prend le caractère d'un serrement au milieu de la poitrine, derrière le sternum et qui irradie vers les mâchoires, les épaules et les bras. Elle s'arrête avec l'effort, se reproduit avec lui ; elle peut s'accompagner de sueurs et de nausées.

Diapositive 138

La Douleur Péricardique

C'est une douleur non liée à l'effort, ressentie comme un coup de poignard, restant localisée, s'accroissant avec la respiration et les mouvements

.

La Douleur

Neurotonique

Elle ne correspond pas à une affection organique du cœur. C'est une douleur en pointe, en piqûres brèves, se répétant sans lien avec l'effort et soulagée par le calme et la quiétude psychologique.

Diapositive 139

LES PALPITATIONS

C'est la perception par le sujet, des battements cardiaques qui normalement ne sont pas ressentis chez l'individu sain. Elles peuvent être associées à une douleur ou à une dyspnée

.

Diapositive 140

LA LIPOTHYMIE ET LA
SYNCOPE

La Lipothymie ou Malaise

C'est une impression angoissante d'évanouissement imminent, avec pâleur, sueur, acouphène, phosphène ou vue trouble. La lipothymie aboutie rarement à un évanouissement ; elle est d'origine vasomotrice et survient à l'occasion d'une émotion ou du premier levé d'un alité.

Diapositive 141

La

Syncope

C'est une perte de connaissance brutale, complète, liée à une soudaine anoxie cérébrale. Elle s'accompagne d'arrêt respiratoire ; elle est brève et réversible. La syncope est provoquée par une pause cardiaque, par une bradycardie, ou par une tachycardie excessive ou par une subite hypotension artérielle. La syncope est donc une mort apparente qui devient effective si elle se prolonge.

Diapositive 142

LES OEDEMES DES MEMBRES INFERIEURS

Les œdèmes des membres inférieurs ne sont pas spécifiques aux affections cardiaques, mais leur groupement avec d'autres signes permet l'orientation vers une atteinte cardiaque ; ces œdèmes ont la particularité d'être déclives, c'est-à-dire qu'il siège à l'endroit le plus bas du corps : sur un malade debout, ils se montreront aux chevilles et aux pieds ; sur un malade couché, on les retrouvera au niveau des fesses, de la région lombaire et des cuisses.

Diapositive 143

LA CLAUDICATION INTERMITTENTE

C'est un symptôme caractéristique d'affection vasculaire (Artériopathie des membres inférieurs). Lorsque le sujet marche, le besoin en oxygène s'accroît ; les artères indurées et rétrécies par l'artériosclérose, ne peuvent assurer, du fait de leur calibre réduit, un apport suffisant de sang. Le manque d'oxygène au membre inférieur provoque une douleur qui amène le patient à interrompre la marche.

Diapositive 144

BIBLIOGRAPHIE

LES

FILLES DE LA

CHARITE (

1970

).

Soins

aux malades et aux

enfants

.

Renne, France.

Communauté

Hôtel de Dieu, 2 rue de l'Hôtel de Dieu

;

P

283-283

PH

RENOU (

1987

).

Cahier

de l'Infirmier N°3 : Appareil

Cardiovasculaire.

Paris CEDEX

06, France.

Edition

Masson, 120

Bd

St

Germain

, 75280

P

88-90